Masterprompt:

Aufgabe
Erstelle auf Basis der hochgeladenen Quellen einen Fragebogen zur Messung von Akzeptanz von KI-gestützten Systemen bei medizinischen Behandlungen bei Patientinnen und Patienten. Schlage dazu eine oder mehrere passende Theorien vor, aus denen die Fragen abgeleitet werden.
Zielgröße
Gegenstand der Befragung ist KI-gestützte Gesundheitsinformationssysteme bei der eigenen Behandlung. Gemessen werden die Nutzungsabsicht und die Faktoren, die sie beeinflussen.
Arbeitsschritte
Arbeite die folgenden Schritte nacheinander ab. Beginne einen Schritt erst, wenn der vorherige abgeschlossen ist.

1. Theorie: Wähle aus den Quellen eine oder mehrere Theorien aus. Begründe die Wahl.
2. Modell und Hypothesen: Leite aus der gewählten Theorie ein Modell ab. Formuliere jeden angenommenen Zusammenhang zwischen zwei Konstrukten als Hypothese. Gib bei jeder Hypothese die Richtung an (+ oder −) und die Quelle, aus der sie abgeleitet ist. Übernimm die Richtung aus dieser Quelle. Maßgeblich ist die dort formulierte Hypothese, nicht das empirische Ergebnis.
3. Konstrukte: Liste alle Konstrukte des Modells auf, die im Fragebogen gemessen werden.
4. Items: Erstelle für jedes Konstrukt 3 bis 5 Items.

Theorievergleich
Gehe in Schritt 1 so vor:

1. Liste alle Theorien auf, die in den Quellen vorkommen.
2. Prüfe für jede Theorie, wie gut sie zur Zielgröße passt.
3. Begründe für jede Theorie, warum du sie aufnimmst oder nicht. Gib diesen Vergleich im Teil „Theorie und Begründung“ aus.

Perspektive
Formuliere alle Items aus Sicht der befragten Person: in der Ich-Form und bezogen auf sich selbst. Formuliere keine Items aus Sicht der Organisation (z. B. mit „wir“ oder „unser Unternehmen“).
Quellenregel
Übernimm Items nur aus Skalen, die in den Quellen stehen. Du darfst nur drei Dinge anpassen: den Gegenstand des Items (die Technologie), die Perspektive und die Sprache. Items aus anderssprachigen Skalen übersetzt du sinngleich ins Deutsche. Alles andere bleibt im Wortlaut gleich, bei übersetzten Items im Sinn gleich. Füge nichts hinzu, lass nichts weg und lege keine Items zusammen. Die Sprache einer Skala ist kein Kriterium für die Theoriewahl. Verwende für den Gegenstand in allen Items dieselbe Bezeichnung. Gib zu jedem Item die Quelle an: den Fragebogen oder das Paper und die Item-Nummer bzw. -Kennung, wie sie in der Quelle steht. Gib nicht den Originaltext an. Wie viele Items du übernimmst, richtet sich nach der Skala in der Quelle:

- Hat die Skala 3 bis 5 Items, übernimm alle.
- Hat die Skala mehr als 5 Items, übernimm die ersten 5 in der Reihenfolge der Quelle.
- Hat die Skala weniger als 3 Items, übernimm alle und ergänze neu formulierte Items, bis das Konstrukt 3 Items hat. Wenn es für ein Konstrukt keine passende Skala in

den Quellen gibt, formuliere die Items neu. Markiere jedes neu formulierte Item als „neu formuliert“ und gib keine Quelle an. Markiere jedes übersetzte Item mit „(übersetzt)“. Markiere ein Item nur dann mit „(invers)“, wenn es in der Originalskala negativ formuliert ist. Ergänze in der Tabelle die Spalte Quelle.

Ausgabeformat

Gib das Ergebnis in genau dieser Reihenfolge aus:

1. Theorie und Begründung
2. Modell mit Hypothesen (Format: H1: Konstrukt A → Konstrukt B (+/−), Quelle: …)
3. Liste der Konstrukte
4. Fragebogen als Tabelle mit den Spalten: Konstrukt | Item | Antwortskala Jede Zeile enthält genau ein Item.

Gib ausschließlich diese vier Teile aus. Füge keine weiteren Abschnitte, Kapitel oder Ergänzungen hinzu.

Ausgabelänge

Gib die Antwortskala nur einmal direkt über der Tabelle an. Die Spalte Antwortskala entfällt.

Response:

1. Theorie und Begründung

Theorievergleich:

In der zugrundeliegenden Quelle werden verschiedene theoretische Ansätze aus der Gesundheitsforschung, den Informationssystemen und der Psychologie aufgeführt1more_horiz:

1. Health Belief Model (HBM) (*Hochbaum, 1958; Rosenstock, 1960, 1974*)26:
    - Passung zur Zielgröße: Das HBM erklärt gesundheitsbezogene Entscheidungen primär über wahrgenommene Bedrohungen und den Nutzen präventiver Maßnahmen2more_horiz. Es eignet sich gut zur Abbildung der krankheitsbezogenen Komponente, lässt jedoch spezifische technologische Akzeptanzfaktoren (z. B. Einstellungen zu Algorithmen oder KI-Eigenschaften) weitgehend unberücksichtigt13.
    - Begründung: Das HBM wird nicht als alleinige Theorie gewählt, geht aber als theoretischer Baustein für die krankheitsbezogene Risikobewertung in das Modell ein13.
2. Protection Motivation Theory (PMT) (*Rogers, 1975; Floyd et al., 2000*)36:
    - Passung zur Zielgröße: Die PMT führt den Dualitätsansatz (*Duality Approach*) ein, bei dem Personen zwischen der Bedrohung durch eine Krankheit (*nonadaptive appraisals*) und der Wirksamkeit einer Bewältigungsmaßnahme (*adaptive appraisals*) abwägen1more_horiz. Dies passt sehr gut zur Situation von Patientinnen und Patienten bei einer medizinischen Behandlungsentscheidung1more_horiz.
    - Begründung: Die PMT wird als zentrales Fundament aufgenommen, da sie das Ausbalancieren von Krankheitsfurcht und Behandlungseffizienz theoretisch begründet1more_horiz.
3. Extended Parallel Process Model (EPPM) (*Witte, 1994, 2009*)36:
    - Passung zur Zielgröße: Das EPPM baut auf dem Dualitätsansatz auf und unterscheidet kognitive Gefahrenabwehr (*danger control*) sowie emotionale

Furchtabwehr (*fear control*)3more_horiz. Es erklärt insbesondere die Entstehung von Krankheits- und Technologiefurcht3more_horiz.
    - Begründung: Das EPPM wird als Ergänzung aufgenommen, um die emotionale Komponente der Furcht im Entscheidungsprozess abzubilden3more_horiz.
4. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) / Technology Acceptance Model (TAM) (*Venkatesh et al., 2012; Davis, 1989*)36:
    - Passung zur Zielgröße: UTAUT2 ist der Standardansatz zur Erklärung technologischer Nutzung auf Basis von Nutzungs- und Aufwandserwartungen sowie verhaltenserleichternden Bedingungen3more_horiz. Es blendet jedoch spezifische krankheitsbezogene Ängste und gesundheitliche Bedrohungen aus1more_horiz.
    - Begründung: UTAUT2 wird für die technologiebezogene Dimension (*adaptive appraisals*) aufgenommen, reicht alleine für den medizinischen Kontext jedoch nicht aus1more_horiz.
5. Reasoned Action Approach (RAA) / Theory of Planned Behavior (TPB) (*Fishbein & Ajzen, 2011; Ajzen, 1991*)46:
    - Passung zur Zielgröße: Der RAA liefert den sozialpsychologischen Rahmen zur Vorhersage von Verhaltensabsichten durch Einstellungen, wahrgenommene Normen und wahrgenommene Verhaltenskontrolle4more_horiz.
    - Begründung: Der RAA wird als Kernstruktur für die Zielgröße Nutzungsabsicht sowie für die Konstrukte Einstellung und wahrgenommene Normen gewählt4more_horiz.
6. Integrierter Dualitäts-Ansatz (Integrated Theoretical Framework) (*Wichmann et al., 2024*)1more_horiz:
    - Passung zur Zielgröße: Dieser Ansatz führt HBM, PMT, EPPM, UTAUT2 und RAA in einem geschlossenen Modell zusammen15. Er balanciert krankheitsbezogene Wahrnehmungen (*nonadaptive appraisals*) und technologiebezogene Wahrnehmungen (*adaptive appraisals*) ab und erreicht bei Behandlungsentscheidungen eine hohe Varianzaufklärung (R^2 zwischen 57,9 % und 81,7 %)1more_horiz.
    - Begründung: Dieses integrierte Modell wird als theoretische Gesamtgrundlage gewählt, da es die vielschichtige Akzeptanz von KI-Systemen bei medizinischen Behandlungen am vollständigsten erklärt1more_horiz.

---

2. Modell mit Hypothesen

Das aus dem integrierten Modell abgeleitete Hypothesensystem umfasst folgende gerichtete Zusammenhänge18more_horiz:

- H1a: Wahrgenommene Bedrohung (Perceived Threats) → Furcht bezüglich der Krankheit (Fear Disease) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)2021
- H1b: Wahrgenommene Bedrohung (Perceived Threats) → Nutzungsabsicht (Intention to Use) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)2021
- H2a: Fehlangepasste Belohnungen (Nonadaptive Rewards) → Furcht bezüglich der Krankheit (Fear Disease) (−), Quelle: Wichmann et al. (2024)21

- H2b: Fehlangepasste Belohnungen (Nonadaptive Rewards) → Nutzungsabsicht (Intention to Use) (−), Quelle: Wichmann et al. (2024)21
- H3: Furcht bezüglich der Krankheit (Fear Disease) → Einstellung gegenüber der Krankheit (Attitude Disease) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)2223
- H4: Einstellung gegenüber der Krankheit (Attitude Disease) → Nutzungsabsicht (Intention to Use) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)23
- H5a: Wahrgenommene Wirksamkeit (Perceived Efficacy) → Furcht bezüglich des KI-Systems (Fear HIS) (−), Quelle: Wichmann et al. (2024)2324
- H5b: Wahrgenommene Wirksamkeit (Perceived Efficacy) → Einstellung gegenüber dem KI-System (Attitude HIS) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)2324
- H5c: Wahrgenommene Wirksamkeit (Perceived Efficacy) → Nutzungsabsicht (Intention to Use) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)2324
- H6: Furcht bezüglich des KI-Systems (Fear HIS) → Einstellung gegenüber dem KI-System (Attitude HIS) (−), Quelle: Wichmann et al. (2024)24
- H7: Einstellung gegenüber dem KI-System (Attitude HIS) → Nutzungsabsicht (Intention to Use) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)25
- H8a: Wahrgenommene Normen (Perceived Norms) → Wahrgenommene Bedrohung (Perceived Threats) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)2526
- H8b: Wahrgenommene Normen (Perceived Norms) → Furcht bezüglich der Krankheit (Fear Disease) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)2526
- H8c: Wahrgenommene Normen (Perceived Norms) → Nutzungsabsicht (Intention to Use) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)2526
- H8d: Wahrgenommene Normen (Perceived Norms) → Einstellung gegenüber dem KI-System (Attitude HIS) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)2526
- H8e: Wahrgenommene Normen (Perceived Norms) → Wahrgenommene Wirksamkeit (Perceived Efficacy) (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)2526
- H8f: Wahrgenommene Normen (Perceived Norms) → Einstellung gegenüber der Krankheit (Attitude Disease) (−), Quelle: Wichmann et al. (2024)2526
- H8g: Wahrgenommene Normen (Perceived Norms) → Furcht bezüglich des KI-Systems (Fear HIS) (−), Quelle: Wichmann et al. (2024)2526
- H8h: Wahrgenommene Normen (Perceived Norms) → Fehlangepasste Belohnungen (Nonadaptive Rewards) (−), Quelle: Wichmann et al. (2024)2526

---

3. Liste der Konstrukte

Das Messmodell umfasst folgende 11 Konstrukte6more_horiz:

1. Wahrgenommene Schwere der Krankheit (*Perceived Severity*)7more_horiz
2. Wahrgenommene Anfälligkeit für die Krankheit (*Perceived Vulnerability*)7more_horiz
3. Fehlangepasste Belohnungen (*Nonadaptive Rewards*)7more_horiz
4. Furcht bezüglich der Krankheit (*Fear Disease*)7more_horiz
5. Einstellung gegenüber der Krankheit (*Attitude Disease*)7more_horiz
6. Wahrgenommene Wirksamkeit des KI-Systems (*Perceived Response Efficacy*)9more_horiz
7. Wahrgenommene Verhaltenskontrolle (*Perceived Behavioral Control*)9more_horiz
8. Wahrgenommene Normen (*Perceived Norms*)9more_horiz
9. Furcht bezüglich des KI-Systems (*Fear HIS*)6more_horiz
10. Einstellung gegenüber dem KI-System (*Attitude HIS*)6more_horiz
11. Nutzungsabsicht (*Intention to Use*)6more_horiz

---

4. Fragebogen als Tabelle
Antwortskala: 7-stufige Likert-Skala (1 = stimme überhaupt nicht zu bis 7 = stimme voll und ganz zu)28

Konstrukt	Item	Quelle
Wahrgenommene Schwere der Krankheit	Ich denke, dass diese Erkrankung schwerwiegende gesundheitliche Folgen für mich hat.	Wichmann et al. (2024) / Ku & Hsieh (2018), Item 1 (übersetzt)28
Wahrgenommene Schwere der Krankheit	Die Beeinträchtigungen durch diese Krankheit wären für mein tägliches Leben sehr hoch.	Wichmann et al. (2024) / Ku & Hsieh (2018), Item 2 (übersetzt)28
Wahrgenommene Schwere der Krankheit	Ich befürchte, dass diese Krankheit meine Lebensqualität langfristig stark verschlechtert.	Wichmann et al. (2024) / Ku & Hsieh (2018), Item 3 (übersetzt)28
Wahrgenommene Schwere der Krankheit	Eine solche Erkrankung stellt ein ernstes gesundheitliches Problem für mich dar.	Wichmann et al. (2024) / Ku & Hsieh (2018), Item 4 (übersetzt)28
Wahrgenommene Schwere der Krankheit	Ich schätze die potenziellen Komplikationen dieser Krankheit als sehr gravierend ein.	Wichmann et al. (2024) / Ku & Hsieh (2018), Item 5 (übersetzt)28
Wahrgenommene Anfälligkeit für die Krankheit	Ich halte es für wahrscheinlich, dass ich von dieser Erkrankung betroffen bin oder sein werde.	Wichmann et al. (2024) / Ku & Hsieh (2018), Item 1 (übersetzt)28
Wahrgenommene Anfälligkeit für die Krankheit	Mein persönliches Risiko, an dieser Erkrankung zu leiden, ist hoch.	Wichmann et al. (2024) / Ku & Hsieh (2018), Item 2 (übersetzt)28
Wahrgenommene Anfälligkeit für die Krankheit	Ich fühle mich anfällig für gesundheitliche Probleme dieser Art.	Wichmann et al. (2024) / Ku & Hsieh (2018), Item 3 (übersetzt)28
Wahrgenommene Anfälligkeit für die Krankheit	Es ist für mich realistisch, dass ich wegen dieser Erkrankung medizinisch behandelt werden muss.	Wichmann et al. (2024) / Ku & Hsieh (2018), Item 4 (übersetzt)28
Fehlangepasste Belohnungen	Wenn ich meine Behandlung wie gewohnt beibehalte, erspare ich mir die Umstellung auf das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem.	Wichmann et al. (2024) / Vance et al. (2012), Item 1 (übersetzt)28
Fehlangepasste Belohnungen	Der Verzicht auf das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem ist für mich bequemer als dessen Nutzung.	Wichmann et al. (2024) / Vance et al. (2012), Item 2

		(übersetzt)28
Fehlangepasste Belohnungen	Es bringt mir Vorteile, wenn ich bei meiner Behandlung vorerst alles beim Alten belasse.	Wichmann et al. (2024) / Vance et al. (2012), Item 3 (übersetzt)28
Furcht bezüglich der Krankheit	Der Gedanke an diese Erkrankung löst in mir Angst aus.	Wichmann et al. (2024) / Izard et al. (1993), Item 1 (übersetzt)28
Furcht bezüglich der Krankheit	Ich fühle mich unruhig, wenn ich an die möglichen Folgen dieser Krankheit denke.	Wichmann et al. (2024) / Izard et al. (1993), Item 2 (übersetzt)28
Furcht bezüglich der Krankheit	Diese Erkrankung macht mir persönlich Sorgen.	Wichmann et al. (2024) / Izard et al. (1993), Item 3 (übersetzt)28
Einstellung gegenüber der Krankheit	Ich halte es für wichtig, mich aktiv mit dieser Erkrankung auseinanderzusetzen.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item 1 (übersetzt)28
Einstellung gegenüber der Krankheit	Es ist für mich sinnvoll, meine gesundheitliche Situation im Hinblick auf diese Krankheit genau zu beobachten.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item 2 (übersetzt)28
Einstellung gegenüber der Krankheit	Ich bewerte eine rechtzeitige Behandlung dieser Krankheit als sehr positiv.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item 3 (übersetzt)28
Einstellung gegenüber der Krankheit	Ich finde es klug, Maßnahmen gegen das Fortschreiten dieser Krankheit zu ergreifen.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item 4 (übersetzt)28
Einstellung gegenüber der Krankheit	Eine aktive Bekämpfung dieser Erkrankung ist für mich von großem Nutzen.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item 5 (übersetzt)28
Wahrgenommene Wirksamkeit des KI-Systems	Ich glaube, dass das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem meine medizinische Behandlung effektiv unterstützt.	Wichmann et al. (2024) / Taheri-Kharameh et al. (2020), Item 1 (übersetzt)28
Wahrgenommene Wirksamkeit des KI-Systems	Die Nutzung des KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems verbessert die Qualität meiner Behandlung.	Wichmann et al. (2024) / Taheri-Kharameh et al. (2020), Item 2

		(übersetzt)28
Wahrgenommene Wirksamkeit des KI-Systems	Das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem ist ein wirksames Mittel zur Unterstützung meiner Gesundheit.	Wichmann et al. (2024) / Taheri-Kharameh et al. (2020), Item 3 (übersetzt)28
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle	Ich habe die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob ich das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem nutze.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item 1 (übersetzt)28
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle	Die Entscheidung für oder gegen das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem liegt ganz bei mir.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item 2 (übersetzt)28
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle	Ich besitze die nötigen Ressourcen und Fähigkeiten, um das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem in meiner Behandlung zu nutzen.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item 3 (übersetzt)28
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle	Es fällt mir leicht, das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem bei meiner Behandlung einzusetzen.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item 4 (übersetzt)28
Wahrgenommene Normen	Personen, die mir wichtig sind, befürworten es, wenn ich das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem bei meiner Behandlung nutze.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item 1 (übersetzt)28
Wahrgenommene Normen	Mein behandelndes medizinisches Fachpersonal erwartet von mir, dass ich das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem verwende.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item 2 (übersetzt)28
Wahrgenommene Normen	Die meisten Menschen in meinem Umfeld, deren Meinung ich schätze, würden das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem bei ihrer Behandlung nutzen.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item 3 (übersetzt)28
Wahrgenommene Normen	Es wird von mir gesellschaftlich erwartet, moderne KI-gestützte Gesundheitsinformationssysteme für meine Gesundheit zu nutzen.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item 4 (übersetzt)28
Furcht bezüglich des KI-Systems	Der Einsatz des KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems bei meiner Behandlung bereitet mir Sorgen.	Wichmann et al. (2024) / Izard et al. (1993), Item 1 (übersetzt)28

Furcht bezüglich des KI-Systems	Ich fühle mich ängstlich, wenn ich daran denke, dass das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem Entscheidungen über meine Behandlung beeinflusst.	Wichmann et al. (2024) / Izard et al. (1993), Item 2 (übersetzt)28
Furcht bezüglich des KI-Systems	Die Vorstellung, von einem KI-gestützten Gesundheitsinformationssystem behandelt zu werden, verunsichert mich.	Wichmann et al. (2024) / Izard et al. (1993), Item 3 (übersetzt)28
Einstellung gegenüber dem KI-System	Ich finde den Einsatz des KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems bei meiner Behandlung positiv.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item 1 (übersetzt)28
Einstellung gegenüber dem KI-System	Die Nutzung des KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems ist für mich eine gute Idee.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item 2 (übersetzt)28
Einstellung gegenüber dem KI-System	Ich stehe dem KI-gestützten Gesundheitsinformationssystem bei medizinischen Behandlungen aufgeschlossen gegenüber.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item 3 (übersetzt)28
Einstellung gegenüber dem KI-System	Ich beurteile den Einsatz des KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems als nützlich für mich.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item 4 (übersetzt)28
Einstellung gegenüber dem KI-System	Insgesamt betrachtet ist das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem für meine Behandlung vorteilhaft.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item 5 (übersetzt)28
Nutzungsabsicht	Ich beabsichtige, das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem bei meiner medizinischen Behandlung zu nutzen.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item 1 (übersetzt)28
Nutzungsabsicht	Ich plane, das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem künftig für meine Behandlung in Anspruch zu nehmen.	Wichmann et al. (2024) / Fishbein & Ajzen (2011), Item 2 (übersetzt)28
Nutzungsabsicht	Ich werde mich dafür entscheiden, das KI-gestüt1. Theorie und Begründung	

Theorievergleich:

In den angegebenen Quellen werden Theorien aus den Bereichen Gesundheitswesen, Informationssysteme und Psychologie thematisiert1more_horiz:

1. Health Belief Model (HBM) (Hochbaum, 1958; Rosenstock, 1960, 1974)26:
2. Passung zur Zielgröße: Das HBM erklärt präventives Gesundheitsverhalten vor allem über krankheitsbezogene Bedrohungen und wahrgenommene Handlungsnutzen2more_horiz. Es deckt zwar die gesundheitliche Komponente gut

ab, vernachlässigt jedoch spezifische Akzeptanzfaktoren bezüglich Informationssystemen und KI-Technologien1more_horiz.

3. Begründung: Es wird nicht als Alleintheorie gewählt, fließt jedoch als Baustein zur Erfassung krankheitsbezogener Risikowahrnehmungen in das Modell ein13.
4. Protection Motivation Theory (PMT) (Rogers, 1975; Floyd et al., 2000)36:
5. Passung zur Zielgröße: Die PMT begründet den Dualitätsansatz (Duality Approach), indem sie die Bedrohung durch eine Krankheit (nonadaptive appraisals) gegenüber der Wirksamkeit einer Schutzmaßnahme (adaptive appraisals) abwägt1more_horiz. Dies entspricht exakt der Entscheidungssituation von Patientinnen und Patienten bei medizinischen Behandlungen1more_horiz.
6. Begründung: Die PMT wird aufgenommen, da sie das theoretische Fundament für das Abwägen von Krankheitsfurcht und Behandlungseffizienz bildet1more_horiz.
7. Extended Parallel Process Model (EPPM) (Witte, 1994, 2009)36:
8. Passung zur Zielgröße: Das EPPM erweitert den Dualitätsansatz um kognitive Prozesse der Gefahrenabwehr (danger control) und emotionale Prozesse der Furchtabwehr (fear control)3more_horiz. Es eignet sich besonders zur Erklärung der Entstehung von Furcht bezüglich Krankheit und KI-System3more_horiz.
9. Begründung: Das EPPM wird zur Fundierung der emotionalen Komponente (Furcht) integriert3more_horiz.
10. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) / Technology Acceptance Model (TAM) (Venkatesh et al., 2012; Davis, 1989)36:
11. Passung zur Zielgröße: Die UTAUT2 erklärt die Nutzung von Technologien über Nutzungs- und Aufwandserwartungen sowie technische Rahmenbedingungen3more_horiz. Medizinische Risiken und krankheitsspezifische Ängste werden jedoch nicht abgebildet1more_horiz.
12. Begründung: Die UTAUT2 wird für die technologiebezogene Akzeptanzdimension integriert, reicht als Einzelmodell für medizinische Behandlungen jedoch nicht aus1more_horiz.
13. Reasoned Action Approach (RAA) / Theory of Planned Behavior (TPB) (Fishbein & Ajzen, 2011; Ajzen, 1991)46:
14. Passung zur Zielgröße: Der RAA bietet einen etablierten sozialpsychologischen Rahmen zur Vorhersage von Nutzungsabsichten durch Einstellungen, wahrgenommene Normen und wahrgenommene Verhaltenskontrolle4more_horiz.
15. Begründung: Der RAA wird als Grundstruktur für die Messung der Zielgröße (Nutzungsabsicht) sowie von Einstellungen und Normen ausgewählt4more_horiz.
16. Integriertes Modell (Integrated Theoretical Framework) (Wichmann et al., 2024)1more_horiz:
17. Passung zur Zielgröße: Das integrierte Modell führt HBM, PMT, EPPM, UTAUT2 und RAA zusammen15. Es verbindet krankheitsbezogene (nonadaptive appraisals) und technologiebezogene Wahrnehmungen (adaptive appraisals) in einem Dualitätsansatz und erreicht eine hohe Varianzaufklärung der Nutzungsabsicht bei medizinischen Behandlungen (R^2 = 57,9 % bis 81,7 %)1more_horiz.
18. Begründung: Das integrierte Modell von Wichmann et al. (2024) wird als theoretische Gesamtgrundlage gewählt, da es alle relevanten Einflussfaktoren der KI-Akzeptanz im medizinischen Kontext vereint1more_horiz.

---

1. Modell mit Hypothesen

H1a: Wahrgenommene Bedrohung → Furcht bezüglich der Krankheit (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)2021 H1b: Wahrgenommene Bedrohung → Nutzungsabsicht (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)2021 H2a: Fehlangepasste Belohnungen → Furcht bezüglich der Krankheit (−), Quelle: Wichmann et al. (2024)21 H2b: Fehlangepasste Belohnungen → Nutzungsabsicht (−), Quelle: Wichmann et al. (2024)21 H3: Furcht bezüglich der Krankheit → Einstellung gegenüber der Krankheit (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)2223 H4: Einstellung gegenüber der Krankheit → Nutzungsabsicht (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)23 H5a: Wahrgenommene Wirksamkeit → Furcht bezüglich des KI-Systems (−), Quelle: Wichmann et al. (2024)2324 H5b: Wahrgenommene Wirksamkeit → Einstellung gegenüber dem KI-System (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)2324 H5c: Wahrgenommene Wirksamkeit → Nutzungsabsicht (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)2324 H6: Furcht bezüglich des KI-Systems → Einstellung gegenüber dem KI-System (−), Quelle: Wichmann et al. (2024)24 H7: Einstellung gegenüber dem KI-System → Nutzungsabsicht (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)25 H8a: Wahrgenommene Normen → Wahrgenommene Bedrohung (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)2526 H8b: Wahrgenommene Normen → Furcht bezüglich der Krankheit (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)2526 H8c: Wahrgenommene Normen → Nutzungsabsicht (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)2526 H8d: Wahrgenommene Normen → Einstellung gegenüber dem KI-System (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)2526 H8e: Wahrgenommene Normen → Wahrgenommene Wirksamkeit (+), Quelle: Wichmann et al. (2024)2526 H8f: Wahrgenommene Normen → Einstellung gegenüber der Krankheit (−), Quelle: Wichmann et al. (2024)2526 H8g: Wahrgenommene Normen → Furcht bezüglich des KI-Systems (−), Quelle: Wichmann et al. (2024)2526 H8h: Wahrgenommene Normen → Fehlangepasste Belohnungen (−), Quelle: Wichmann et al. (2024)2526

---

1. Liste der Konstrukte
2. Wahrgenommene Schwere der Krankheit (Perceived Severity)7more_horiz
3. Wahrgenommene Anfälligkeit für die Krankheit (Perceived Vulnerability)7more_horiz
4. Fehlangepasste Belohnungen (Nonadaptive Rewards)7more_horiz
5. Furcht bezüglich der Krankheit (Fear Disease)7more_horiz
6. Einstellung gegenüber der Krankheit (Attitude Disease)7more_horiz
7. Wahrgenommene Wirksamkeit des KI-Systems (Perceived Response Efficacy)9more_horiz
8. Wahrgenommene Verhaltenskontrolle (Perceived Behavioral Control)9more_horiz
9. Wahrgenommene Normen (Perceived Norms)9more_horiz
10. Furcht bezüglich des KI-Systems (Fear HIS)6more_horiz
11. Einstellung gegenüber dem KI-System (Attitude HIS)6more_horiz
12. Nutzungsabsicht (Intention to Use)6more_horiz

---

1. Fragebogen als Tabelle

Antwortskala: 7-stufige Likert-Skala (1 = stimme überhaupt nicht zu bis 7 = stimme voll und ganz zu)28

Konstrukt	Item	Quelle
Wahrgenommene Schwere der Krankheit	Ich denke, dass diese Erkrankung schwerwiegende gesundheitliche Folgen für mich hat. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Ku & Hsieh (2018), Item 128
Wahrgenommene	Die Beeinträchtigungen durch diese Krankheit	Paper Fragebogen

Schwere der Krankheit	wären für mein tägliches Leben sehr hoch. (übersetzt)	1.pdf, Ku & Hsieh (2018), Item 228
Wahrgenommene Schwere der Krankheit	Ich befürchte, dass diese Krankheit meine Lebensqualität langfristig stark verschlechtert. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Ku & Hsieh (2018), Item 328
Wahrgenommene Schwere der Krankheit	Eine solche Erkrankung stellt ein ernstes gesundheitliches Problem für mich dar. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Ku & Hsieh (2018), Item 428
Wahrgenommene Schwere der Krankheit	Ich schätze die potenziellen Komplikationen dieser Krankheit als sehr gravierend ein. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Ku & Hsieh (2018), Item 528
Wahrgenommene Anfälligkeit für die Krankheit	Ich halte es für wahrscheinlich, dass ich von dieser Erkrankung betroffen bin oder sein werde. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Ku & Hsieh (2018), Item 128
Wahrgenommene Anfälligkeit für die Krankheit	Mein persönliches Risiko, an dieser Erkrankung zu leiden, ist hoch. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Ku & Hsieh (2018), Item 228
Wahrgenommene Anfälligkeit für die Krankheit	Ich fühle mich anfällig für gesundheitliche Probleme dieser Art. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Ku & Hsieh (2018), Item 328
Wahrgenommene Anfälligkeit für die Krankheit	Es ist für mich realistisch, dass ich wegen dieser Erkrankung medizinisch behandelt werden muss. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Ku & Hsieh (2018), Item 428
Fehlangepasste Belohnungen	Wenn ich meine Behandlung wie gewohnt beibehalte, erspare ich mir die Umstellung auf das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Vance et al. (2012), Item 128
Fehlangepasste Belohnungen	Der Verzicht auf das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem ist für mich bequemer als dessen Nutzung. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Vance et al. (2012), Item 228
Fehlangepasste Belohnungen	Es bringt mir Vorteile, wenn ich bei meiner Behandlung vorerst alles beim Alten belasse. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Vance et al. (2012), Item 328
Furcht bezüglich der Krankheit	Der Gedanke an diese Erkrankung löst in mir Angst aus. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Izard et al. (1993), Item 128
Furcht bezüglich der Krankheit	Ich fühle mich unruhig, wenn ich an die möglichen Folgen dieser Krankheit denke. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Izard et al. (1993), Item 228
Furcht bezüglich der Krankheit	Diese Erkrankung macht mir persönlich Sorgen. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Izard et al. (1993), Item 328
Einstellung gegenüber der Krankheit	Ich halte es für wichtig, mich aktiv mit dieser Erkrankung auseinanderzusetzen. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Fishbein & Ajzen (2011), Item 128

Einstellung gegenüber der Krankheit	Es ist für mich sinnvoll, meine gesundheitliche Situation im Hinblick auf diese Krankheit genau zu beobachten. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Fishbein & Ajzen (2011), Item 228
Einstellung gegenüber der Krankheit	Ich bewerte eine rechtzeitige Behandlung dieser Krankheit als sehr positiv. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Fishbein & Ajzen (2011), Item 328
Einstellung gegenüber der Krankheit	Ich finde es klug, Maßnahmen gegen das Fortschreiten dieser Krankheit zu ergreifen. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Fishbein & Ajzen (2011), Item 428
Einstellung gegenüber der Krankheit	Eine aktive Bekämpfung dieser Erkrankung ist für mich von großem Nutzen. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Fishbein & Ajzen (2011), Item 528
Wahrgenommene Wirksamkeit des KI-Systems	Ich glaube, dass das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem meine medizinische Behandlung effektiv unterstützt. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Taheri-Kharameh et al. (2020), Item 128
Wahrgenommene Wirksamkeit des KI-Systems	Die Nutzung des KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems verbessert die Qualität meiner Behandlung. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Taheri-Kharameh et al. (2020), Item 228
Wahrgenommene Wirksamkeit des KI-Systems	Das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem ist ein wirksames Mittel zur Unterstützung meiner Gesundheit. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Taheri-Kharameh et al. (2020), Item 328
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle	Ich habe die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob ich das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem nutze. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Fishbein & Ajzen (2011), Item 128
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle	Die Entscheidung für oder gegen das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem liegt ganz bei mir. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Fishbein & Ajzen (2011), Item 228
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle	Ich besitze die nötigen Ressourcen und Fähigkeiten, um das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem in meiner Behandlung zu nutzen. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Fishbein & Ajzen (2011), Item 328
Wahrgenommene Verhaltenskontrolle	Es fällt mir leicht, das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem bei meiner Behandlung einzusetzen. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Fishbein & Ajzen (2011), Item 428
Wahrgenommene Normen	Personen, die mir wichtig sind, befürworten es, wenn ich das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem bei meiner	Paper Fragebogen 1.pdf, Fishbein & Ajzen (2011), Item

	Behandlung nutze. (übersetzt)	128
Wahrgenommene Normen	Mein behandelndes medizinisches Fachpersonal erwartet von mir, dass ich das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem verwende. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Fishbein & Ajzen (2011), Item 228
Wahrgenommene Normen	Die meisten Menschen in meinem Umfeld, deren Meinung ich schätze, würden das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem bei ihrer Behandlung nutzen. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Fishbein & Ajzen (2011), Item 328
Wahrgenommene Normen	Es wird von mir gesellschaftlich erwartet, moderne KI-gestützte Gesundheitsinformationssysteme für meine Gesundheit zu nutzen. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Fishbein & Ajzen (2011), Item 428
Furcht bezüglich des KI-Systems	Der Einsatz des KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems bei meiner Behandlung bereitet mir Sorgen. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Izard et al. (1993), Item 128
Furcht bezüglich des KI-Systems	Ich fühle mich ängstlich, wenn ich daran denke, dass das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem Entscheidungen über meine Behandlung beeinflusst. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Izard et al. (1993), Item 228
Furcht bezüglich des KI-Systems	Die Vorstellung, von einem KI-gestützten Gesundheitsinformationssystem behandelt zu werden, verunsichert mich. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Izard et al. (1993), Item 328
Einstellung gegenüber dem KI-System	Ich finde den Einsatz des KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems bei meiner Behandlung positiv. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Fishbein & Ajzen (2011), Item 128
Einstellung gegenüber dem KI-System	Die Nutzung des KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems ist für mich eine gute Idee. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Fishbein & Ajzen (2011), Item 228
Einstellung gegenüber dem KI-System	Ich stehe dem KI-gestützten Gesundheitsinformationssystem bei medizinischen Behandlungen aufgeschlossen gegenüber. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Fishbein & Ajzen (2011), Item 328
Einstellung gegenüber dem KI-System	Ich beurteile den Einsatz des KI-gestützten Gesundheitsinformationssystems als nützlich für mich. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Fishbein & Ajzen (2011), Item 428
Einstellung gegenüber dem KI-System	Insgesamt betrachtet ist das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem für meine Behandlung vorteilhaft. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Fishbein & Ajzen (2011), Item 528
Nutzungsabsicht	Ich beabsichtige, das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem bei meiner medizinischen Behandlung zu nutzen. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Fishbein & Ajzen (2011), Item

		128
Nutzungsabsicht	Ich plane, das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem künftig für meine Behandlung in Anspruch zu nehmen. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Fishbein & Ajzen (2011), Item 228
Nutzungsabsicht	Ich werde mich dafür entscheiden, das KI-gestützte Gesundheitsinformationssystem bei meiner Behandlung zu einzusetzen. (übersetzt)	Paper Fragebogen 1.pdf, Fishbein & Ajzen (2011), Item 3